

Ograniczenie *alkoholu*

Alkohol jest depresantem ośrodkowego układu nerwowego. Sabotuje wszystko, co inne narzędzia próbują naprawić.

CZAS: 15 min nauki + 4 tyg. monitorowania 4 tygodnie

ŹRÓDŁO: NICE NG222 (2022); Boden & Fergusson (2011); Conner i wsp. (2009); Mason i wsp. (2008)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **4 mechanizmy**, którymi alkohol pogłębia depresję (sekcja 01) i **3 strategie zmiany** (sekcja 02). Wybierz **jedną** i prowadź dziennik przez 4 tyg. (sekcja 03). Cel: nie abstynencja totalna (chyba że uzależnienie), ale *świadomość* i ograniczenie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Alkohol jest **depresantem** ośrodkowego układu nerwowego — wprost obniża aktywność mózgu. Boden & Fergusson (2011): nadużywanie alkoholu i depresja są w **relacji dwukierunkowej**. Conner i wsp. (2009): osoby z depresją, które ograniczają alkohol, mają 2× *wiekszy* wskaźnik remisji. Mechanizmy: (1) *burzy strukturę snu*, (2) *odwadnia mózg* — „zjazd” trwa 24–48 h, (3) *obciąża wątrobę* — wolniejszy metabolizm leków antydepresyjnych, (4) *tłumi GABA i serotoninę* długoterminowo. NICE NG222: ograniczenie alkoholu jest **standardowym elementem** leczenia depresji, nie opcją.

01 = Cztery mechanizmy szkodenia

1 · BURZY SEN

Skraca latencję snu (zasypiasz szybciej), ale *blokuje REM*, wywołuje pobudki o 3–4 rano, wczesne wybudzenia. Po 2 lampkach wina sen jest 30–40 % gorszy.

2 · „ALKOHOŁOWY ZJAZD” NAZAJUTRZ

Mózg *odwodniony*, zaburzona równowaga elektrolitowa, pobudzony kortyzol. Lęk i obniżony nastrój trwają 24–48 h po pić.

3 · OBCIĄŻA WĄTROBĘ

Wątroba metabolizuje SSRI, SNRI, leki nasenne. Alkohol *spowalnia* ten proces — leki działają słabiej lub silniej, nieprzewidywalnie.

4 · TŁUMI NEUROPRZEKAŹNIKI

Po wielu tygodniach regularnego picia: *obniżona* produkcja GABA, serotoniny, dopaminy. Mózg „przyzwyczaja się” — bez alkoholu czuje się gorzej.

02 ● Trzy strategie zmiany

A · PEŁNA ABSTYNENCJA

4 tyg. *testu*

Najmocniejszy efekt. Po 4 tyg. zauważasz różnicę: lepszy sen, mniej lęku, większa energia. *Eksperyment*, nie zobowiązanie na zawsze.

Polecane przy: ciężkiej depresji, brania leków, problemach ze snem.

B · 3 DNI „SUCHE”

tygodniowo

3 wybrane dni w tygodniu bez alkoholu (np. pn–wt–śr). Mózg ma szansę odpocząć, sen się reguluje.

Polecane przy: łagodnej–umiarkowanej depresji, picie społeczne.

C · LIMIT JEDNOSTEK

max 1–2 jedn./dzień

Maksymalnie 1 jednostka (lampka wina 100 ml / piwo 250 ml / 25 ml mocnego) na dzień. Nigdy 2+ z rzędu.

Polecane przy: chcesz mieć picie towarzyskie, nie chcesz tracić wszystkiego.

⚠ **Czerwone flagi uzależnienia** — jeśli rozpoznajesz: konsultacja z lekarzem, NIE samodzielne odstawienie. *Picie codziennie ponad 4 jednostki, drżenie ręki rano, pić by „się uspokoić”, ukrywanie picia, niepowodzenia w ograniczaniu*. Wsparcie: AA, terapia uzależnień, lekarz POZ.

03

— Dziennik — 4 tygodnie

Codziennie zapisz: liczba jednostek alkoholu + jakość snu + nastrój dnia.

	LICZBA JEDNOSTEK 0/1/ 2/3+	JAKOŚĆ SNU 0-10	NASTRÓJ DNIA 0- 10	OBSERWACJE
Pn1				
Wt1				
Śr1				
Cz1				
Pt1				
Sb1				
Nd1				
Pn2				
Wt2				
Śr2				
Cz2				
Pt2				
Sb2				
Nd2				
Pn3				
Wt3				
Śr3				
Cz3				
Pt3				
Sb3				
Nd3				
Pn4				
Wt4				
Śr4				
Cz4				
Pt4				
Sb4				
Nd4				

Efekty w czasie: dzień 3-4: lepszy sen (REM się odbudowuje), więcej energii rano. Dzień 7-10: niższy lęk, mniejsza reaktywność emocjonalna. Tydzień 2-4: *znaczący spadek* objawów depresyjnych (Conner 2009: BDI spadek o 4-7 pkt). **Częsta trudność:** życie towarzyskie zorganizowane wokół alkoholu. Eksperyment: zaproponuj kawę / spacer / kolację bez alkoholu. Większość osób się zgadza — często same szukały pretekstu. Najtrudniejsze są *pierwsze 2 tygodnie* — później mózg uczy się, że odpoczynek i radość nie wymagają alkoholu.